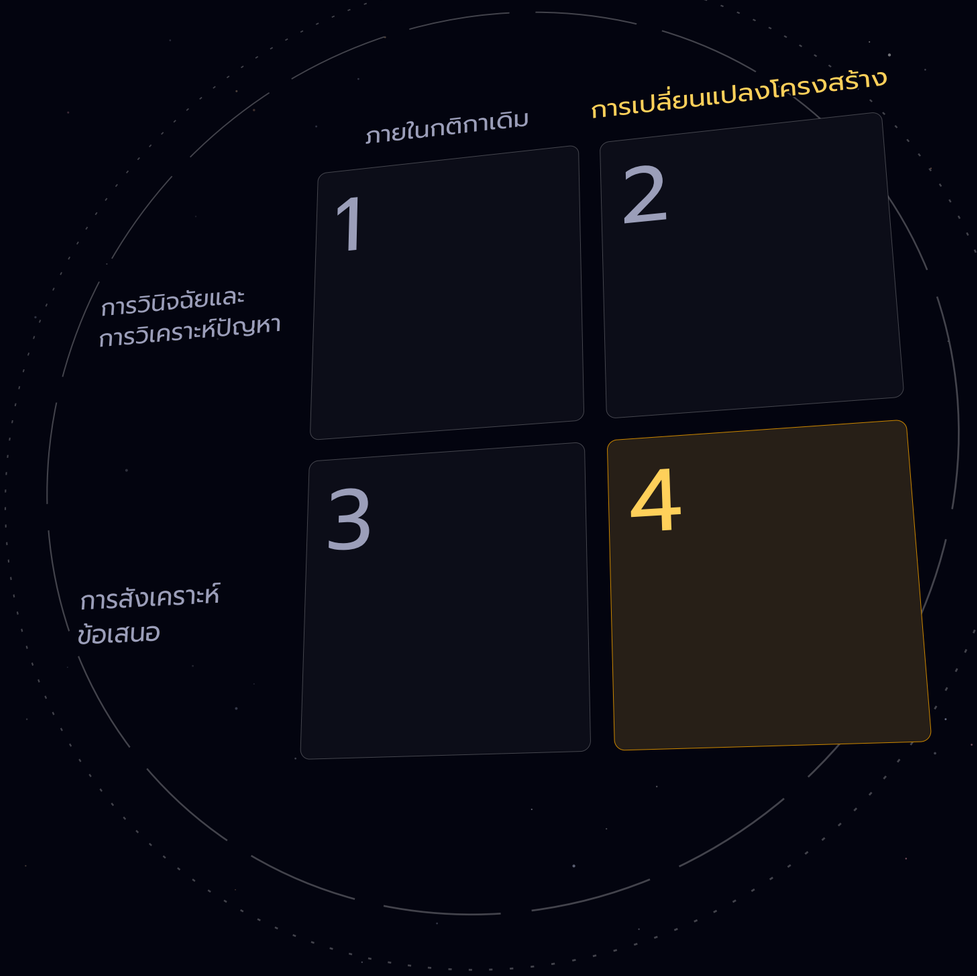
การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ก้าวต่อไป: ศึกษาวิธีเปลี่ยนกติกา

ว่าด้วยก้าวต่อไปของการสร้างองค์ความรู้และบทบาทของนักวิชาการ
ในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข

ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิ่งที่ได้ยินจากวงเสวนา · การตีความของคณะวิจัย

ตัวเลขเดียวกัน อาจนำไปสู่ข้อเสนอที่ต่างกัน

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง
และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ
ระหว่างรัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ
และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เมื่อกรอบตำแหน่งเต็ม ปรับสูตรก็ช่วยได้จำกัด

เมื่อกรอบตำแหน่งเต็ม
การเปลี่ยนสูตรจัดสรรให้ผลจำกัด
ต้องถามต่อว่าจะเพิ่มตำแหน่งที่ใด
และใครจ่ายเงินเดือน
ผลการศึกษาช่วยให้เห็นว่ากติกาใดควรทบทวน

- จุด = ผลการศึกษาภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

→ ผลเหล่านี้ช่วยระบุว่ากติกาใดควรทบทวน

ความเพียงพอ: จำนวนแพทย์เป็นร้อยละของเป้าหมายตัวอย่าง 1:1,000 ประชากร



กรอบเต็ม: ทุกสูตรได้ 33.7% ของเป้าหมาย
วัดใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปี 2583

เพิ่มตามสัดส่วนใช้ตำแหน่ง 2.0 เท่า
ของการวางตามจำเป็น

เพิ่มลูกจ้าง: แพทย์ใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดถึงเป้า
รพ.จ่าย กระจายได้สำเร็จตามเป้า 39.6%
ส่วนกลางจ่ายและจัดตามจำเป็น 48.8%

8 จังหวัดอยู่กลุ่มต่ำสุดทั้งสี่วิธีวัด

แพทย์เฉพาะทาง 63.5% อยู่ในสถานพยาบาล
กลุ่มบนหนึ่งในสิบ

คนบ่นมาก: นโยบายกำลังคน 60% รายได้ 41%
แต่สองเรื่องนี้ไม่สัมพันธ์ชัดกับการคิดจะลาออก
ที่สัมพันธ์ชัด: ทีม ชีวิตในพื้นที่ การฝึก การยอมรับ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

แผนภาพเชิงแนวคิด

สี่ช่องช่วยแยก คำถามของงานวิจัย

แกนแรกแยก**การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา**
คือการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไร
ออกจาก**การสังเคราะห์ข้อเสนอ**ว่าควรทำอะไร
แกนที่สองแยกงาน**ภายในกติกาเดิม**
ซึ่งยอมรับตำแหน่ง ผู้จ้าง และข้อมูลที่มีอยู่
เป็นเงื่อนไข ออกจากงาน
ที่มุ่ง**การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง**ของกติกาเหล่านั้น

Radical ในที่นี้
หมายถึง**แก้ถึงรากของปัญหา**



Lindblom · ค่อย ๆ ปรับจากทางเลือกที่ใกล้กัน

Etzioni · พิจารณาทางเลือกกว้างก่อน แล้วลงมือทีละขั้น

ดัดแปลงจากการนำเสนอของ Geoff Mulgan ในการประชุม SPA Conference 2026 · Lindblom 1959 · Etzioni 1967 · รายงานการศึกษา บทที่ 11

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

การตีความของคณะวิจัย

งานนี้ตอบโจทย์กติกาเดิม ยังขาดงานเปลี่ยนระบบ

การนับแพทย์ การตรวจยอดคนเข้าออก
และการสำรวจผู้ทำงาน
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม
ส่วนแบบจำลองจัดสรร
และมาตรการการธำรงคนในระบบ
เป็นข้อเสนอภายในกติกาเดิม

งานวิจัยตามโจทย์ผู้ให้ทุน
ช่วยตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้

> เราบอกได้ว่าผลจำลองต่างกันอย่างไร
> ภายใต้เงื่อนไขที่ตั้งไว้
> แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเปลี่ยนระบบจริงแล้ว
> ทางใดจะดีกว่า และใครต้องรับภาระ
>
> สรุปจากรายงานการศึกษา บทที่ 11

	ภายในกติกาเดิม	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา	1 ● นับแพทย์และเทียบหลายวิธี ● ตรวจยอดคนเข้าออก ● สำรวจเหตุผลที่อยู่หรือคิดออก วิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม	2 ● ใครนิยามว่าขาดแคลน ● วิชาชีพกำหนดจำนวนอย่างไร ● ใครรับภาระดูแล วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง
การสังเคราะห์ข้อเสนอ	3 ● จำลองการจัดแพทย์ใหม่ ● เสนอมาตรการการธำรงคนในระบบ ข้อเสนอภายในกติกาเดิม	4 ● เสนอให้ทบทวนกติกาทุกปี ยังขาดงาน เปรียบเทียบทางเลือก ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ | การตีความของคณะวิจัย

ทำไมต้องศึกษาวิธีเปลี่ยนระบบ และต้องรู้อะไรก่อน

ถ้าพื้นที่รับแพทย์เพิ่มไม่ได้เพราะไม่มีตำแหน่ง
การปรับสูตรจัดสรรอย่างเดียวก็ช่วยได้จำกัด
จึงต้องศึกษาว่าจะเปลี่ยนกติกาอย่างไร

แต่ข้อเสนอเปลี่ยนระบบต้องตรวจสอบได้ ต้องมี**หลักฐานว่าปัญหาเกิดอย่างไร**จากช่องที่หนึ่ง **ใครได้ประโยชน์ ใครรับภาระ**จากช่องที่สอง และ**ทดลองทีละขั้นและกำหนดเวลาทบทวน**จากช่องที่สาม

เงื่อนไขของข้อเสนอเปลี่ยนระบบ



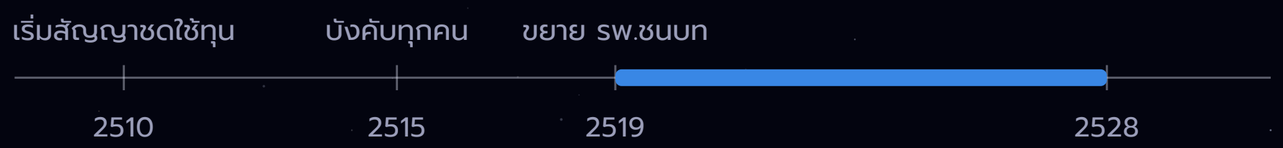
เหตุผลที่หนึ่ง · ผลการศึกษาชี้ข้อจำกัดที่ต้องแก้

กรอบเต็ม ทุกสูตรได้ความเพียงพอ	ผลจำลอง: ไม่มีตำแหน่งรองรับ ในสิบห้าปี	อยู่กลุ่มต่ำสุด ทั้งสี่วิธีวัด
33.7%	8,272 คน*	8 จังหวัด

ความเพียงพอ: จำนวนแพทย์เป็นร้อยละของเป้าหมายตัวอย่าง 1:1,000 ประชากร
* สมมติให้มีแพทย์พร้อมจัดสรรปีละสองพันห้าร้อยคน และเพิ่มตำแหน่งร้อยละห้าต่อรอบ

เหตุผลที่สอง · การตัดสินใจวันนี้มีผลอีกหลายปี

เหตุผลที่สาม · ไทยเคยเปลี่ยนระบบเพื่อกระจายแพทย์



รพ.ชนบท 200 → 425 แห่ง แพทย์ชนบท 300 → 1,162 คน อีสาน/กทม. 21 เท่า → 8.6 เท่า

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ ◐ การตีความของคณะวิจัย

หกแผนวิจัยเพื่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

หกแผนงานเพื่อศึกษาทางเลือกเปลี่ยนระบบ
แต่ละแผนต้องระบุปัญหาที่จะแก้ กติกาที่จะเปลี่ยน และหลักฐานที่ยังต้องหาเพิ่ม

ⓘ ข้อเสนอของคณะผู้เขียน ยังไม่มีหน่วยงานรับเป็นแผนงาน

1 บริการสุขภาพในพื้นที่ หลังถ่ายโอนให้ท้องถิ่น

ชุมชน

ใครกำกับ ใครจัดงบ
ให้ทีมปฐมภูมิทำงานต่อและก้าวหน้าได้แม้เปลี่ยนนายจ้าง

รพ.สต. ถ่ายโอนให้ อบจ. แล้ว 5,176 จาก 9,878 แห่ง
อบจ. 17 จาก 76 แห่งรับครบ 9 แห่งยังไม่รับ
HSIU สวรส. ข้อมูล ณ 7 ก.ย. 2569

2 รับคนจากพื้นที่ เชื่อมการฝึกกับงานและความก้าวหน้า

ชุมชนและเศรษฐกิจ

การรับคนในพื้นที่ ฝึกในภูมิภาค และมีทางก้าวหน้า
ช่วยให้คนทำงานในพื้นที่ต่อได้เพียงใด

ทำงานในจังหวัดภูมิลำเนา สัมพันธ์กับการคิดย้ายออก
จากพื้นที่น้อยลง (อัตราส่วนออดส์ 0.44) แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์ชัดเจนกับการคิดลาออกจากสังกัด

3 ผู้จ้างและตำแหน่ง ที่รองรับบริการที่ประชาชนควรได้รับ

เศรษฐกิจและรัฐ

ผู้จ้างและผู้จ่ายแบบใดช่วยกระจายคน ใครรับต้นทุน
และคนทำงานมั่นคงเพียงใด

รพ.จ่าย กระจายได้สำเร็จตามเป้า 39.6%
ส่วนกลางจ่ายและจัดตามความจำเป็น 48.8%
แพทย์ใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุด ปี 2583 เทียบเป้า 1:1,000

4 ความรับผิดชอบของเอกชน และแพทย์ที่ทำงานทั้งรัฐและเอกชน

เศรษฐกิจ

การจ่ายเงินและเงื่อนไขอนุญาตช่วยให้เอกชนร่วมดูแลพื้นที่ขาด
บริการได้หรือไม่

แพทย์เฉพาะทางทุกสังกัด 63.5% อยู่ในสถานพยาบาลกลุ่ม
ที่มีมากที่สุดหนึ่งในสิบ

5 การจัดงานดูแล และสนับสนุนผู้ดูแล

สังคมและเศรษฐกิจ

การจ้างผู้ดูแลในชุมชน คนช่วยดูแลแทนชั่วคราว และบริการ
ระยะยาว ลดภาระให้ใคร อย่างไร

ผู้ดูแลหลักเป็นคนในครอบครัว 92–94%
จากระบบบริการ 2–4% (ผู้สูงอายุที่พึ่งพิง สสช. 2567)

6 ร่วมตัดสินว่าคนพอหรือไม่ และจะจัดสรรอย่างไร

สังคม

การให้ผู้เกี่ยวข้องใช้แบบจำลองร่วมกัน ช่วยเลือกเกณฑ์
และยอมรับผลได้อย่างไร

ผลจำลอง: ใช้ประชากรหรือปริมาณบริการ
แพทย์ใหม่สะสมสิบห้าปีในปทุมธานีต่าง 499 คน

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ | แผนภาพเชิงแนวคิด

จะรู้ได้อย่างไร ว่าข้อเสนอเปลี่ยนระบบใช้ได้จริง

เมื่อข้อเสนอจะเปลี่ยนผู้จ้าง งบ หรือกติกา
เราต้องประเมินด้วยว่าใครจะทำให้เกิดขึ้น ใครรับภาระ
และถ้าไม่ได้ผลจะปรับหรือหยุดอย่างไร

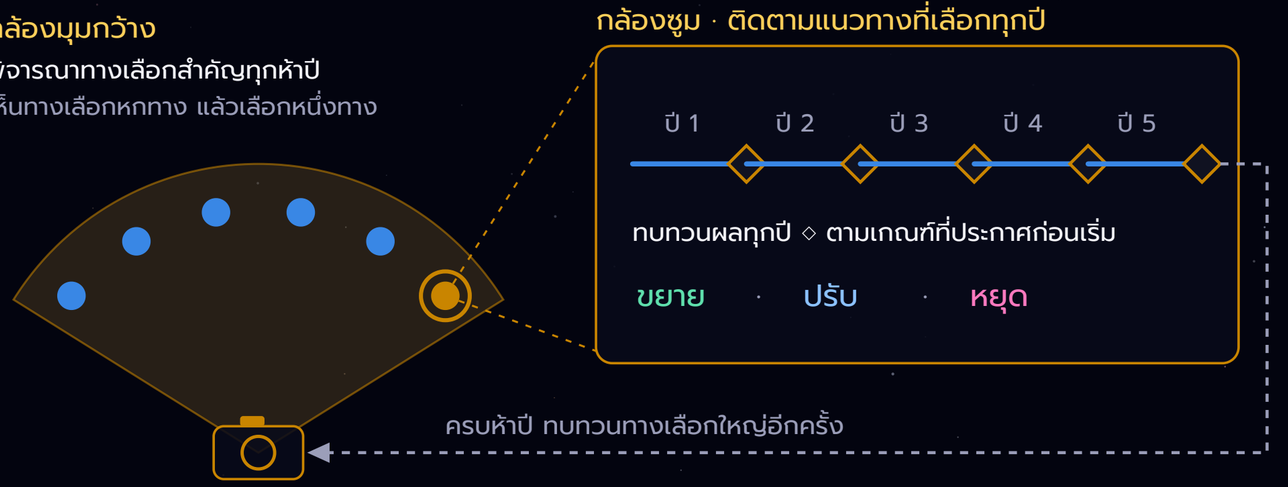
Etzioni: เลือกทิศทางระยะยาว
แล้วลงมือทีละขั้น

ผลจำลองตามสมมติฐาน
ยังต้องทดสอบกับการเปลี่ยนจริง

คำถามห้าข้อที่ข้อเสนอเปลี่ยนระบบต้องตอบ



Etzioni · กล้องสองตัวทำงานคู่กัน



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ | การตีความของคณะวิจัย

งานที่เริ่มได้ทันที เพื่อเตรียมเปลี่ยนกติกา

เริ่มจากข้อมูลและงานจัดสรรที่ต้องใช้รอบหน้า พร้อมเก็บผลไว้ประเมินการเปลี่ยนกติกาในอนาคต
งานระยะสั้นจึงช่วยให้ตัดสินใจเรื่องระยะยาวได้ดีขึ้น

ช่องที่ 1
วิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม

- ตรวจยอดแพทย์กับข้อมูลเข้าออก
- เชื่อมข้อมูลรายคนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
- วัดเวลาทำงานจริง: ผู้ตอบ 34% คิดเกษียณก่อน หรือลดเวลางาน
- ติดตามผู้ที่ออกแล้ว

ช่องที่ 2
วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง

- ใครกำหนดตำแหน่ง ด้วยเหตุผลใด
- ใครนับว่าขาด เพื่อขอทรัพยากรอะไร
- งานเอกชนและงานดูแลมีผลต่อการย้ายหรือไม่ อย่างไร

ช่องที่ 3
ข้อเสนอภายในกติกาเดิม

- เปรียบเทียบหลายเกณฑ์จัดสรร
- เพิ่มตำแหน่งตามความจำเป็น
- ส่งแพทย์ตามตำแหน่งว่างจริง
- กำหนดกลุ่ม เวลา และผลที่จะวัดก่อนเริ่ม

4 ใช้หลักฐานจากทั้งสามช่องประเมินข้อเสนอเปลี่ยนกติกา

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · บทบาทของนักวิชาการ ◐ การตีความของคณะวิจัย

นักวิชาการไม่ได้ออกแบบสังคมแทนคนอื่น แต่ทำให้ทางเลือกตรวจสอบและโต้แย้งได้

	ภายในกติกาเดิม	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา	1 งานวิชาชีพ สร้างความรู้ในสาขา	2 งานวิพากษ์ ตั้งคำถามต่อสิ่งที่เชื่อ
การสังเคราะห์ข้อเสนอ	3 งานนโยบาย เสนอวิธีแก้ปัญหา	4 งานสาธารณะ เรียนรู้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

Burawoy · งานสี่แบบ เทียบกับสี่ช่องโดยประมาณ

Weiss · ใช้งานวิจัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และใช้ทำความเข้าใจปัญหาใหม่

บทบาท	ช่วยเรื่องใด	สิ่งที่ต้องระวัง	สิ่งที่ควรทำ
1 ผู้วิเคราะห์และผู้ดูแลข้อมูล	ตัวเลขที่บอกว่านับใคร เทียบอะไร และยังไม่แน่ใจเรื่องใด	คิดว่าข้อมูลที่หน่วยงานเก็บครอบคลุมปัญหาทั้งหมด	บอกขอบเขต ตรวจยอดกับข้อมูลเข้าออก รายงานส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้
2 ผู้วิพากษ์	ชี้ว่ากติกาจำกัดใคร เอื้อใคร และให้ใครรับภาระ	อธิบายอย่างเดียว ยังไม่ตรวจด้วยหลักฐาน	บอกว่าใครทำอะไร เกิดผลอย่างไร ยอมปรับคำอธิบายเมื่อหลักฐานไม่สนับสนุน
3 ที่ปรึกษานโยบาย	ทางเลือกที่ใช้ได้รอบหน้า พร้อมผลดีและภาระที่ต้องแลก	ตอบตามโจทย์ผู้ว่าจ้าง จนมองข้ามปัญหาของคนอื่น	แยกผลจริง ผลจำลอง และข้อเสนอ กำหนดเกณฑ์ก่อนเริ่ม รายงานผลไม่ผ่านและแหล่งทุน
4 ผู้ร่วมพัฒนาทางเลือกกับประชาชน	ทางเลือกระยะยาวที่ประเมินได้ด้วยเกณฑ์เปิดเผย	พูดแทนผู้อื่น หรือทำให้ความเชื่อตนดูเหมือนข้อสรุปวิชาการ	ตอบคำถามห้าข้อ ร่วมงานกับผู้ทำงาน ผู้ดูแล ชุมชน และบันทึกความเห็นต่าง

Weiss 1979 · Burawoy 2005 · รายงานการศึกษา บทที่ 11 ตารางบทบาทของนักวิชาการ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · บทบาทของนักวิชาการ ◐ การตีความของคณะวิจัย

ทำงานใกล้ผู้กำหนดนโยบายอย่างไร ให้ตรวจสอบได้

การทำงานใกล้ผู้กำหนดนโยบายช่วยให้ใช้ความรู้ได้เร็ว
แต่ต้องเปิดให้คนนอกเครือข่ายตรวจสอบและโต้แย้งได้ด้วย

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คนภายนอกตรวจได้ว่า เราเลือกวิธีไหน ตัดสินจากหลักฐานอะไร และ**อาจมีความเอนเอียงตรงใด**

Harris · เครือข่ายข้าราชการนักปฏิรูป
ช่วยรวบรวมกำลังและทรัพยากร จนผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

Selway · กติกาการเลือกตั้งและพรรค
ขบวนการวิชาชีพสำคัญ
แต่ให้น้ำหนักกับกติกาการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมากกว่า

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อทำงานใกล้กัน

- โจทย์วิจัยจำกัดอยู่แค่อำนาจของหน่วยงาน
- คนในเครือข่ายตรวจสอบกันเอง
- คนนอกไม่มีช่องทางโต้แย้งเกณฑ์

ความรับผิดชอบต่อความสมเหตุสมผล (A4R)

- **เปิดเผย**เหตุผล
- ใช้เหตุผลที่**เกี่ยวข้อง**และรับฟังกันได้
- มี**ช่องทางคัดค้าน**และทบทวน
- มี**ผู้กำกับ**ให้ทำตามหลัก

สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้ทำแล้ว

- ✓ ประกาศเกณฑ์ก่อนคำนวณและรายงานผลไม่ผ่าน
- ✓ กำหนดผลหลักของการสำรวจก่อนวิเคราะห์
- ✓ ปรับข้อเสนอเรื่องภาระงานเมื่อข้อมูลไม่สนับสนุน
- ✓ เปิดรหัสโปรแกรมและเครื่องมือให้ตรวจ
- ✓ แยกข้อมูลรายคนออกจากผลเผยแพร่

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

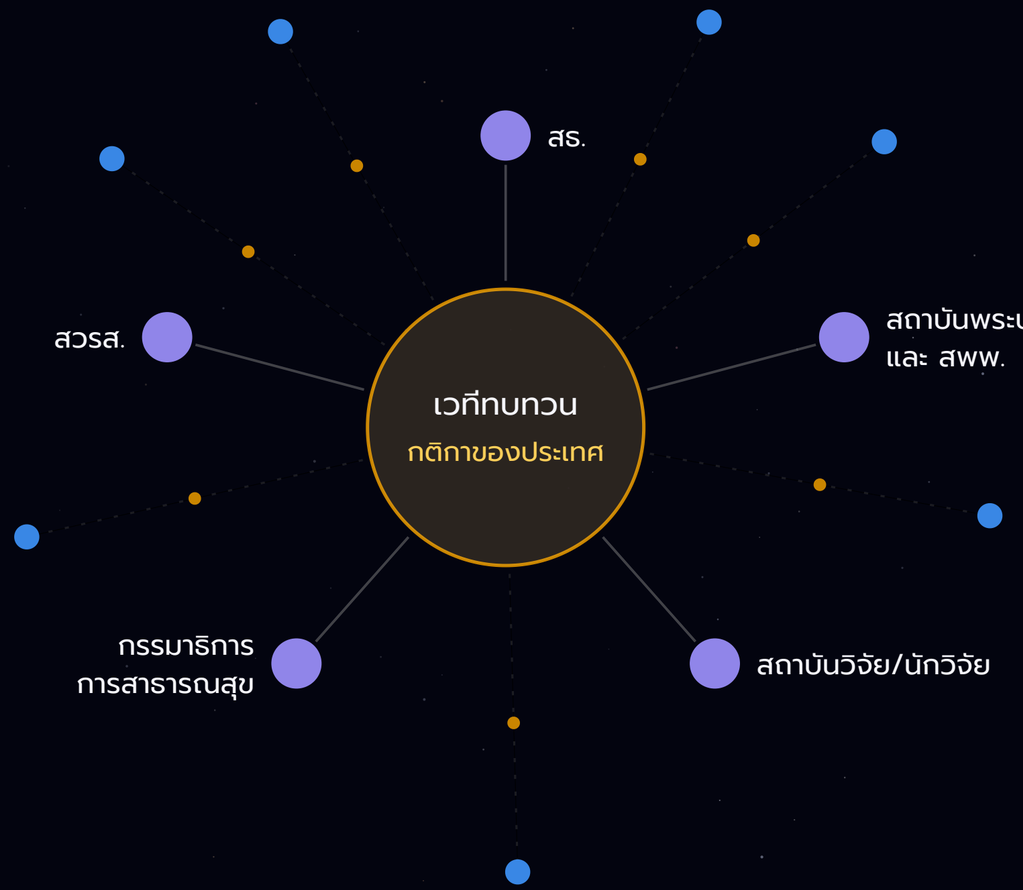
ปิด · การตีความของคณะวิจัย

ร่วมสร้าง ข้อมูลและทีมวิจัยระยะยาว ข้อเสนอเพื่อหารือ

การศึกษาทางเลือกเปลี่ยนระบบต้องมีข้อมูลต่อเนื่อง ติดตามผู้จบแต่ละรุ่น และมีนักวิเคราะห์ในพื้นที่ จึงต้องร่วมมือกันระยะยาว

- **สธ.** ตรวจยอดและเชื่อมข้อมูลรายคนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
- **สถาบันพระบรมราชชนก และ สพพ.** ติดตามผู้จบแต่ละรุ่นจากโครงการผลิตเพื่อพื้นที่
- **สถาบันวิจัย/นักวิจัย** ทดสอบสาเหตุและจำลองการเลือกงาน
- **กรรมาธิการการสาธารณสุข** ติดตามการใช้หลักฐานตัดสินนโยบาย
- **สวรส.** สนับสนุนเครือข่ายวิจัยระยะยาว

ⓘ ข้อเสนอเพื่อหารือ ยังไม่ได้หารือหรือตกลงกับหน่วยงานใด



จุดฟ้า: นักวิเคราะห์ในเขตและจังหวัด · จุดทอง: ผลจากพื้นที่ที่ส่งกลับสู่เวทีทบทวน (Ostrom)

Ostrom 2010 · Jasanoff 2004 · รายงานการศึกษา บทที่ 11

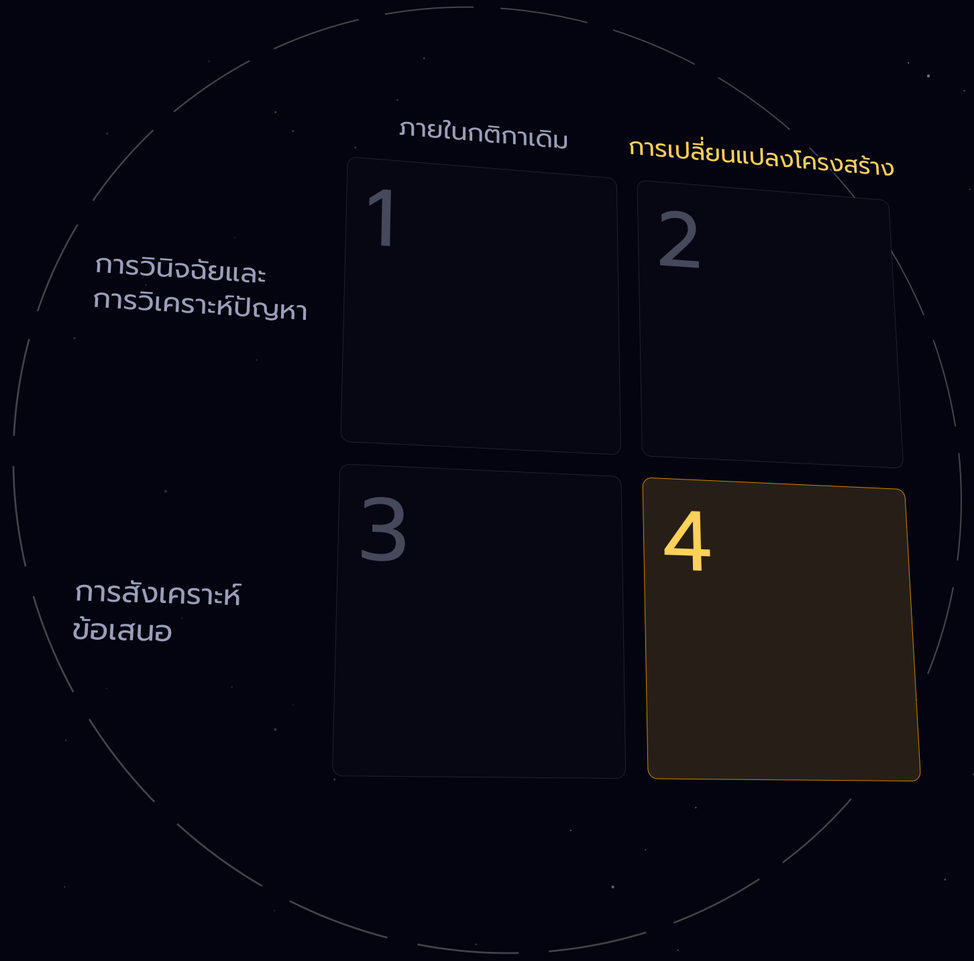
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อความปิด | การตีความของคณะวิจัย

แบบจำลองช่วยให้เห็นผลและภาระส่วนการเลือกเป็นเรื่องที่ต้องร่วมตัดสินใจ

นักวิชาการช่วยให้สังคมเปรียบเทียบทางเลือกและตรวจสอบเหตุผลได้
เมื่อทดลองแล้วต้องทบทวนผล
เพื่อให้ข้อเสนอเปลี่ยนระบบมีหลักฐานรองรับมากขึ้น

ขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะวิจัย ผู้ร่วมเสวนา และทุกท่าน



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)